

间可达8小时以上,最长可达12小时。口服极易吸收,服后2小时可出现血药高峰,不代谢为水杨酸,几乎全部结合为葡萄糖醛酸酐的代谢物,72小时后约有80~95%从尿中排除。常用量250~500mg/日,分二次服;

(4)扑炎痛(Benorylate)系扑热息痛一阿斯匹林酯。

5.防止不合理的配伍用药⁴⁾如避免与消炎痛、保泰松、降血糖药、皮质激素等伍用。

6.原料生产中严格控制杂质乙酰水杨酸酐的含量,制订控制的标准以减少过敏反应。

7.用H₂-受体阻断药甲氰咪胍和阿斯匹林同服,减少对胃肠道损伤。

(陈冠容综合)

参 考 文 献

- 1.林志彬:生理科学进展,10:272,1979
- 2.西德专利,923,623
- 3.马传康:中级医刊,3:6,1982
- 4.唐镜波:药物相互作用,189,河南科技出版社,郑州,1981
- 5.美国专利4,206,209,(1980)

胃复安引起的锥体外系反应的讨论

北京市结核病医院药房 方娟娟

胃复安(Metoclopramidum, pasper-tin)亦名灭吐灵。我院临床上用于治疗对氨基水杨酸钠、四环素、复方新诺明等引起的呕吐。但从1981年以来曾发生4例口服胃复安引起的锥体外系反应。临床表现为服药后1至3天,突然发生斜颈,双眼球上翻凝视、扭转性痉挛,肌肉震颤,四肢肌肉抽搐,流涎,舌肌运动障碍,语音不清,发作时意识清楚。停用胃复安后上述症状消失,未再复发。

该药为脑内多巴胺受体阻断剂。多巴胺

在纹状体内为抑制性递质,纹状体内还含有乙酰胆碱是兴奋性递质。两者在功能上互相制约,当纹状体内多巴胺减少或多巴胺受体被阻断时,则乙酰胆碱在功能上处于优势。临床上表现是肌张力变化与不自主运动等锥体外系反应。

据文献报告每日总量超过每公斤体重500μg/kg,便可能发生锥体外系反应。上述4例剂量都超过此范围,消化系统疾病用时常与抗胆碱药合用,为避免上述反应出现,可控制在20mg/日为宜。

通过药历表调查药物相互作用

大连铁路医院药剂科 牟春生 周凤荫

一、制药历表的目的与方法

合理用药使病人得到最好的药物治疗是当前临床用药急待解决的重要问题。临床治

疗上大多采用合并给药,其目的不外是为了得到有益的药物相互作用(协同、累加等作用)但在合并用药中也有不良相互作用的情况(如拮抗、毒副反应增强等)其中有的可能

被察觉到,如产生出血、低血糖休克、惊厥或高血压危象、心跳停止或死亡等,但大多易被临床疏忽未能发觉,如药效的部分减弱、神经系统、血液系统、其他脏器器官的慢性损害等,因此医师和药师都应重视合并用药时药物的不良相互作用。我院抽查了50份80年住院1个月以上病人的病历,根据病历制作了每个病人住院期间用药的药历表,再通过药历表着重于药物不良相互作用的调查。

药历表的制作(见表1、2)便于看出同一时间合并用药的种类及药量、服用疗程,便于进行用药分析。此次所制药历表的资料来源只限于病历中的口服药,对注射药与临床化验或临床检查用药皆未列入。

二、根据药历表分析用药情况

利用药历表不但能一目了然看出病人用药情况,还可检查合并用药的相互作用。以表(1、2)为例患者虽病情好转而出院,但从药历表中可以看到有些药物组合还有产生不良相互作用的机遇。如表1中的双氢克尿塞与土霉素并用能引起BUN上升损害肾脏^[1];表2中的①健胃片、富马酸铁、冠心苏合丸(内含硃砂)都能降低土霉素的作用;②冠心苏合丸能降低颠茄、麻杏止咳糖浆的作用;③麻杏止咳糖浆中的麻黄碱与去甲肾上腺素并用易发生血压显著上升及心律失常^[2];④长期应用甲氧苄氨嘧啶(超过一周)能影响叶酸代谢,处方中没有补给叶酸^[3];⑤氨茶碱可减弱甚至取消潘生丁的冠脉扩张作用^[4]。

表1 药 历 表

内科

×××,男,52岁,住院期间:1980.5.17~8.25共39日

诊断 1)风湿性心脏病 2)心房纤颤

3)充血性心力衰竭Ⅱ° 4)瘀血性肝硬化

按上法分析,50份病例中可能产生相互

作用的药物(见表3)。

日期	17/5	24	31	7/6	14	21	28
处方药名							
狄戈辛				0.25mg			
双氢克尿塞	75mg	50mg	75mg	50mg			
10%氯化钾溶液		30ml				21/6	
土霉素		2.0g					
维生素C	24/5		0.6g				
维生素B ₁		31/5 4/6	0.06g				
安心	28/5	5mg		5mg		16/6	
酵母		5/6		3.0g			

表2 药 历 表

内科

×××男73岁住院期间:1980.10.14~12.24共71日

诊断 1)内外混合痔并出血 2)继发性贫血

3)冠心病 4)动脉硬化 5)慢性支气管炎

日期	14/10	21	28	4/11	11	18	25	2/12	9	16	24
处方药名											
土霉素				18/11				19/12			
维生素C		2.0g					2.0g			2.0g	
TMP					0.6g						
冠心苏合丸	18/10			0.4g							
VitB ₁	4片										
颠茄片	16/10			0.03g							
氯化钾	0.072g				4.5g						
氨茶碱	17/10			0.6g							
路丁				0.06g							
潘生丁	18/10		28/10				8/12	0.15g			
D-860	2/10			3.0g							
VitB ₁₂				0.03g							
VitB ₆				300ug							
VitK				0.624g							
去甲肾上腺素				9.6mg	17/11		25/11~27/11				
优降糖	7.5mg	28/10			7.5mg						
降糖灵	0.075g										
健胃片	6片										
酵母				3.0g							
黄连素片	28/10			13/11							
麻杏止咳糖浆	6片				2/12	8/12					
10%氯化钾溶液				30ml		11/12					
扑热息痛片				19/11		3/12~6/12					
富马酸铁						1.5g		2.2g			

除了可能发生相互作用外,尚有多种同效药物的合用,如硝酸甘油+消心痛+脉心导敏+潘生丁(1例)。更为严重的是对某些疾病投给了禁忌药,如对动脉硬化症患者投给去甲肾上腺素^[6](1例);对心力衰竭患者投给异搏停^[6](1例);对冠心病患者投给喘息定^[7](1例),共占总数的6%,不能不引起重视。以上事实说明我们过去对药物相互作用和有效合理安全用药方面的知识很不够,这就迫使我们今后必须学

表 3

见于药历表中可能产生相互作用的药物组合

药 名	同用药名	出现次数	可 能 产 生 的 相 互 作 用
四 环 素 族 抗 生 素	制 酸 药	8	pH 升高可使四环素族抗生素溶解性降低。
	铁 剂	3	四环素族抗生素可和钙、镁、铝、铁、铋等金属离子络合影响其吸收。
	活 性 炭	1	口服抗生素可被活性炭吸附。
	乳 酶 生	2	抑菌性抗生素及黄连素对乳酸菌有抑制作用。
	双氢克尿塞	12	四环素族抗生素与所有利尿药并用皆可引起 BUN 升高。
冠 心 苏 合 丸	胃 蛋 白 酶	1	重金属盐可影响胃蛋白酶的作用，
左 旋 多 巴	氯 丙 嗪	1	氯丙嗪能阻断中枢神经系统的多巴胺受体。
	维 生 素 B ₆	1	维生素 B ₆ 能拮抗左旋多巴的作用。
苯 妥 英 钠	强 力 霉 素	1	苯妥英钠能缩短强力霉素的半衰期降低其作用。
	狄 戈 辛	1	苯妥英钠有酶促作用可使狄戈辛作用降低。
	利 眠 宁	1	利眠宁能抑制苯妥英钠代谢使其血浓度增高作用增强。
	安 定	3	作用同上
安 定	咪 喃 唑 酮	1	咪喃唑酮连用 5 天以上可产生单胺氧化酶抑制剂的作用，此后若并用安定，可能增强安定的作用，不宜并用，若必须并用应慎重。
	氯 丙 嗪	1	氯丙嗪能增强安定的作用，不宜并用，若必须并用应慎重。
维 生 素 类	活 性 炭	2	活性炭能吸附维生素、抗生素、激素、生物碱等而影响其吸收。
安 体 舒 通	氯 化 钾	1	安体舒通有排钠滞钾作用，一般禁止与钾剂合用。
阿 托 品	氯 丙 嗪	1	氯丙嗪能增强阿托品的作用。
颠 茄 片	异 烟 肼	1	可以并用，但抗胆碱药的副作用可能增强，也有记载说，异烟肼的副作用可能增强。
阿 司 匹 林	消 炎 痛	1	阿斯匹林能降低消炎痛在消化道中的吸收或延迟吸收。
6-巯基嘌呤	别 嘌 呤 醇	1	别嘌呤醇能阻碍 6-巯基嘌呤的代谢。
强 的 松	活 性 炭	1	活性炭能吸附激素、抗生素、维生素、生物碱等而影响其吸收。
	消 炎 痛	1	并用后可使消化道溃疡发生率增高，或使消化道溃疡进一步恶化。
双 氢 克 尿 塞	氯 磺 丙 脲	1	利尿药有拮抗降血糖药的降血糖作用。
麻 杏 止 咳 糖 浆	去 甲 肾 上 腺 素	1	麻黄碱与去甲肾上腺素并用，易发生血压显著上升及心律失常，应相隔 3~4 小时分别使用。
心 得 安	扑 尔 敏	1	扑尔敏能对抗心得安的抗 β 受体作用，但能加强心得安的奎尼丁样作用。
利 福 平	异 烟 肼	1	能增加肝毒性发生率。
	苯 巴 比 妥	1	苯巴比妥能显著降低利福平的血药浓度。
潘 生 丁	氨 茶 碱	5	氨茶碱可减弱，甚至取消潘生丁的冠脉扩张作用。

习和开展临床药学,随时与医师商讨,当好临床用药参谋。

三、小结

1. 在这次调查的50份药历表中认为有药物相互作用机遇的有32份,占64%,有产生不良相互作用的药物组合共52对,(降效30对,毒副反应增强22对),这里未包括多种药物合用时可能产生更为复杂的相互作用。以上指的是可能发生药物不良相互作用的机遇,并非一定都能发生,因为药物相互作用还和用药量、用药时间长短、患者的身体状态等有关。有相互作用的并用药,对某些患者可能引起剧烈反应,对某些患者仅能引起轻微反应,对某些患者也可能不发生反应。我们不能因此而持侥幸心理,应重视可能发生的一面;当遇到对某些病人必须并用有药物不良相互作用的处方时,可与医师商量改变给药途径或用药时间或减低药量或在监护下给药等办法以保证患者用药安全有效,而不可把在体内有不良药物相互作用的处方一律看成是不可投药的。

2. 在这50份药历表中,一天内口服药最多者为22种,最少者为2种,10种以上者有40%,5种以下者有16%,据报道^[3],同时服用1~5种药物的病人药物相互作用

发生率可达18.6%,同时服用6种或更多种药物时,发生率可上升至81.4%。由此可见,同时服用的药物种类越多,相互作用的发生率越高。当然这种发生率指的是有益与不良的总和。国外已把多种药物的处方称之为杂凑给药(Polypharmacy)或过多给药^[9]。由此可见,合理用药是医师和药师应该共同关注的重要问题。

参考文献

1. 关口庆二等:药物相互作用,第2版,125页,医齿药出版,1978(日文)
2. 唐静波:药物相互作用,第388页,河南科技出版社,1981
3. 上海第一医学院主编:医用药理学,第1版,第75页,人民卫生出版社,1979
4. 陈孝治等:临床用药问题解答,第101页,湖南科技出版社,1980
5. 中山医学院主编:药理学,第1版,第149页,人民卫生出版社,1979
6. 同上,208页
7. 同上,152页
8. 孙永乐:图解药物的相互作用,第1版,第2页,科技文献出版社重庆分社,1979
9. 毛凤斐等:医院药学杂志,1(1):39,1981

可能诱发感染的药物

河北邯郸妇幼保健院 刘连升

现代医学的发展,使人们认识到药物不但有治疗作用,而且也有许多药物可以诱发感染^[1]。

临床早就报道,老年患者使用三环类抗抑郁剂,易于发生口及舌部粘膜溃疡。并认为,凡对泪液、唾液、鼻腔的分泌有影响的

药物,都易于诱发眼部,口腔粘膜及唾液腺感染。

长期应用肾上腺皮质激素的患者,在手术期间或手术后有较高伤口感染发生率。这是由于肾上腺皮质激素对大部分淋巴组织有损害作用,抑制了炎症反应及免疫功能。因